

LE SYNDROME HÉMOLYTIQUE ET URÉMIQUE

Le **syndrome hémolytique et urémique (SHU)** est une microangiopathie thrombotique (MAT) caractérisée par la triade clinique classique : **anémie hémolytique mécanique, thrombopénie de consommation** et **insuffisance rénale aiguë** secondaire à une atteinte endothéliale glomérulaire.

Étiologies et classification

- **SHU typique** : lié à une infection digestive, principalement à *Escherichia coli* productrice de shigatoxine (STEC), induisant une activation endothéliale, une inflammation et une thrombose microvasculaire.
- **SHU atypique** : secondaire à un dysfonctionnement du système du complément, souvent d'origine génétique (mutation des régulateurs du complément comme CFH, CFI, MCP/CD46), entraînant une activation incontrôlée et chronique du complément.

Physiopathologie

La lésion endothéliale entraîne une activation plaquettaire et une consommation de facteur Willebrand, favorisant la formation de microthrombi dans la microcirculation, en particulier au niveau rénal. Cela conduit à une **hémolyse mécanique intravasculaire**, une **ischémie tissulaire** et une **défaillance rénale aiguë** par nécrose tubulaire et atteinte glomérulaire.

Clinique

- **Anémie hémolytique** : pâleur, asthénie, ictère, augmentation de la LDH, schizocytes sur frottis sanguin.
- **Thrombopénie** : purpura, pétéchies, saignements muqueux.
- **Atteinte rénale** : oligo-anurie, hématurie, protéinurie, élévation de la créatininémie, HTA.
- **Formes sévères** : atteinte neurologique (confusion, convulsions), myocardique, digestive.

Diagnostic biologique

- **Hémolyse mécanique** : schizocytes > 2%, LDH ↑, haptoglobine ↓, bilirubine indirecte ↑.
- **Thrombopénie** modérée à sévère sans CIVD.
- **Atteinte rénale** : protéinurie, hématurie, IRA fonctionnelle ou organique.
- Recherche de STEC dans les selles (PCR, culture).
- Dosage du complément, recherche de mutations génétiques dans le SHU atypique.

Prise en charge

□ **SHU typique** : prise en charge symptomatique avec réhydratation, correction des troubles hydro-électrolytiques, dialyse si nécessaire.

□ **SHU atypique** : plasmaphérèses en phase aiguë, éculizumab (anti-C5) en traitement spécifique.

!!!!!! **Éviter les antibiotiques et les anti-diarrhéiques** dans le SHU STEC, car ils augmentent le risque de libération de toxines.

Pronostic et complications

Le SHU typique guérit dans 70-85% des cas mais peut évoluer vers une **insuffisance rénale chronique**. Le SHU atypique a un **risque élevé de récurrence et d'évolution vers une IR terminale**, nécessitant un suivi néphrologique étroit.